## ***Requerimientos Funcionales:***

**1. Gestión de agenda médica**

- RF-01: Definir disponibilidad horaria mensual del médico (días, horarios y duración de consulta).
- RF-02: Apertura automática de agenda pública según la configuración del médico.
- RF-03: Bloqueo de agenda por licencias, feriados o imprevistos del profesional.
- RF-04: Consulta de agenda y hoja de trabajo diaria del médico.
- RF-27: Modificación de los horarios de atención por el administrador.
- RF-28: Marcación de un turno como no disponible por el médico.

**2. Reserva de turnos**

- RF-05: Búsqueda y filtrado de turnos disponibles por especialidad, médico o fecha.
- RF-06: Confirmación de reserva de turno por parte del paciente.
- RF-07: Envío automatizado de correos electrónicos de confirmación y recordatorios de cita.
- RF-08: Cancelación y reprogramación de turnos por parte del paciente.
- RF-09:Permitir al médico o al personal administrativo cancelar un turno o suspender un periodo de tiempo por motivos imprevistos o de fuerza mayor.
- RF-10: Notificación automática al paciente por cancelación de turno
- RF-29: Registro de la asistencia del paciente al turno
- RF-30: Reserva de turno por el administrador a solicitud presencial

**3. Gestión de vacunas**

- RF-11: Registro y actualización del inventario/stock de vacunas disponibles por parte de las enfermeras.
- RF-12: Asignación y reserva de turnos específicos para vacunación.
- RF-13: Generación de alertas automáticas por bajo stock de vacunas críticas.
- RF-31: Aprobación de la solicitud de turno de vacunación por la enfermera
- RF-32: Definición del nivel de stock crítico de cada vacuna
- RF-33: Alta de nuevas vacunas en el inventario por la enfermera

**4. Gestión de pagos y coberturas**

- RF-14: Registro de cobertura médica/obra social del paciente y validación.
- RF-15: Procesamiento de pagos para consultas particulares.
- RF-16: Emisión y descarga de comprobantes/facturas digitales.
- RF-34: Definición del valor de la consulta por cada médico
- RF-35: Cobro de la totalidad del turno ante la inasistencia del paciente

**5. Historial clínico**

- RF-17: Carga de diagnósticos, indicaciones y tratamientos en la ficha digital por parte del médico.
- RF-18: Consulta remota del historial médico por parte del paciente.

**6. Reportes administrativos**

- RF-19: Generación de reporte de cantidad de turnos atendidos/cancelados por especialidad.
- RF-20: Generación de reporte de stock y consumo de vacunas.
- RF-21: Generación de reporte de ingresos por pagos y ausentismo de pacientes.

**7. Acceso,autenticación y gestión de usuario**

- RF-22: Registro autogestionado de cuenta de paciente
- RF-23: Inicio de sesión mediante correo electrónico
- RF-24: Creación de cuentas del personal de la sala por el administrador
- RF-25: Diferenciación de la interfaz según el rol del usuario
- RF-26: Ejercicio de las funciones de médico y de paciente por el administrador

## ***Planillas de los requerimientos:***

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Carga de horarios de atención. |
| **ID** | RF-01 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a cada médico cargar sus horarios de atención disponibles. |
| **Términos** | Horarios de atención (franja horaria que un profesional habilita en un tiempo determinado) |
| **Justificación** | Es la base del sistema, sin esta información no es posible ofrecerles turnos a los pacientes. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-23 |
| **Documentos** | Cronograma / Planilla de Horarios del Profesional. |
| **Argumentos de factibilidad** | Todos los médicos ya cuentan con un horario fijo lo cual simplifica la carga inicial, se puede implementar fácilmente. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: Un médico carga su horario y se verifica que su agenda se actualice correctamente reflejando los horarios cargados. |

.

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Apertura automática de agenda pública según la configuración del médico. |
| **ID** | RF-02 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe generar y publicar automáticamente la agenda de turnos disponibles para los pacientes, a partir de la configuración de disponibilidad cargada por el médico (RF-01) |
| **Términos** | Agenda pública (vista de turnos disponibles visible y reservable por los pacientes) |
| **Justificación** | Automatiza el proceso de puesta a disposición de turnos, evitando que un administrativo deba publicarlos manualmente. |

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-01 |
| **Documentos** | Agenda Pública de Turnos. |
| **Argumentos de factibilidad** | Es una transformación directa de los datos de RF-01, no requiere lógica compleja adicional. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: Al guardar la disponibilidad de un médico, verificar que los turnos correspondientes aparezcan disponibles en la vista de reserva del paciente. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Bloque de agenda médica por licencias,feriados o imprevistos |
| **ID** | RF-03 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a cada médico (o al personal administrativo en su nombre) seleccionar y bloquear días completos, franjas horarias o turnos específicos de su agenda mensual previamente publicada. Al confirmar el bloqueo por licencias, feriados o imprevistos, el sistema deshabilita la posibilidad de nuevas reservas en esa franja y marca los turnos como suspendidos/cancelados. |
| **Términos** | Bloqueo de agenda |
| **Justificación** | Otorga flexibilidad a los profesionales de la salud para gestionar imprevistos personales o licencias, previniendo que los pacientes reserven turnos en horarios en los que el médico no estará disponible en la sala médica. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-02 (Apertura automática de agenda pública). |
| **Documentos** | Reglamento Interno de Licencias y Francos del Personal Médico |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza su cumplimiento ejecutando una consulta de actualización (UPDATE) en la base de datos relacional sobre la tabla de turnos para el rango de fechas seleccionado, lo que cambiará su estado a 'Bloqueado' e impedirá que el servicio de búsqueda pública devuelva esos horarios a los pacientes. |
| **Métodos de verificación** | Prueba funcional ingresando con el rol Médico, seleccionando una fecha con agenda publicada, aplicando un bloqueo por licencia y verificando desde la interfaz de Paciente que dichos horarios ya no aparecen disponibles para reservar. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Consulta de agenda y hoja de trabajo diaria del médico. |
| **ID** | RF-04 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al médico visualizar su grilla de turnos reservados por día/semana, filtrando por estado de turno: confirmado, atendido, ausente, e identificando los datos del paciente. |
| **Términos** | Médico, Paciente, Turno, Estado de turno. |
| **Justificación** | Es necesario para que el médico pueda conocer y organizar su jornada laboral, verificar quienes son los pacientes agendados y llevar el control de presentismo, lo cual es el paso previo y necesario para luego cargar diagnósticos y tratamientos en el historial clínico. |
| **Prioridad** | Alta. |
| **Dependencias** | RF-06, RF-29 |
| **Documentos** | Reglamento interno de organización de turnos y agendas médicas de la sala, Manual de procedimientos operativos de atención médica en consultorios externos, Ley Nº 25.326 (Protección de Datos Personales). |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza su cumplimiento mediante la implementación de consultas a la base de datos que filtren los turnos asociados al ID del médico que inició sesión, acotados por la fecha seleccionada. Los estados se pueden manejar como atributos actualizables en el modelo de datos de cada turno. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: Un médico inicia sesión con sus credenciales y al acceder a la pantalla de agendas/turnos verifica si solo ve sus turnos correspondientes para el día o semana seleccionados, junto con los datos de los pacientes. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Búsqueda y filtrado de turnos disponibles |
| **ID** | RF-05 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al paciente buscar y filtrar los turnos disponibles por especialidad, médico o fecha. |
| **Términos** | Filtrado (mecanismo de búsqueda que acota los resultados según criterios seleccionados por el usuario). Especialidad (clínico, pediatra, traumatólogo) |
| **Justificación** | Es el punto de entrada del flujo de reserva, sin una búsqueda eficaz el paciente no puede encontrar un turno acorde a su necesidad. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-02 |
| **Documentos** | Agenda Pública de Turnos. |
| **Argumentos de factibilidad** | Es una consulta estándar sobre la base de turnos disponibles con filtros combinables, no presenta complejidad técnica relevante. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: Aplicar combinaciones de filtros y verificar que los |

| | |
|---|---|
| | resultados devueltos por el sistema correspondan exactamente a los criterios seleccionados. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Confirmación de reserva de turno por parte del paciente |
| **ID** | RF-06 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al paciente confirmar su asistencia a su turno previamente reservado, cambiando su estado a “confirmado” |
| **Términos** | Paciente, Turno, Notificación, Estado de reserva, Token de confirmación. |
| **Justificación** | Reducir la tasa de ausentismo, optimizar la disponibilidad del personal médico y posibilitar la reasignación de turnos no confirmados |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-05, RF-07 |
| **Documentos** | Reglamento de admisión y asignación de turnos de la sala médica. Ley Nacional Nº 26.529 (Derechos del Paciente, Historia Clínica y Autonomía de la Voluntad). Ley Nº 25.326 (Protección de Datos Personales). |
| **Argumentos de factibilidad** | Implementación técnicamente viables mediante el uso de tokens únicos de confirmación de un solo uso en enlaces web o respuestas automatizadas por canal de mensajería estándar. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales e integración end-to-end enviando un evento de confirmación de prueba y verificando que el registro del turno actualice su estado a "Confirmado" en la base de datos de manera inmediata. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Envío automatizado de correos electrónicos de confirmación y recordatorios de cita |
| **ID** | RF-07 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico al paciente al momento de confirmar su reserva junto con los detalles de la misma y enviar recordatorios a medida que la fecha se acerque, |

| | |
|---|---|
| **Términos** | Correo de confirmación, recordatorio. |
| **Justificación** | Es necesario para evitar la tasa de ausentismo sin previo aviso y asegurar que el paciente disponga de un comprobante digital con la información de su cita médica. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-05 |
| **Documentos** | Política institucional de comunicaciones digitales y notificaciones a pacientes. Ley Nº 25.326 (Protección de Datos Personales). Ley Nº 24.240 (Defensa del Consumidor / Información al Usuario). |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza mediante la integración del backend con un servicio o API de envío de correos electrónicos (como SMTP, Resend o SendGrid). Para los recordatorios, se implementarán tareas programadas (cron jobs) que consulten periódicamente la base de datos en busca de turnos próximos a cumplirse y disparen los correos correspondientes. |
| **Métodos de verificación** | El paciente ingresa al sistema con su usuario de paciente, realiza una reserva de turno y verifica en la bandeja de entrada de su correo si recibió un mail de confirmación con los datos correctos de su turno.<br>El día anterior al del turno deberá revisar si recibió un recordatorio a su bandeja de entrada. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Cancelación y reprogramación de turnos por parte del paciente. |
| **ID** | RF-08 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al paciente cancelar un turno confirmado o reprogramarlo a un nuevo horario disponible. |
| **Términos** | Reprogramación (cancelación de un turno existente con reserva simultánea de un nuevo turno, sin perder la relación con la solicitud original) |
| **Justificación** | Brinda autonomía al paciente ante cambios de disponibilidad, reduciendo la carga administrativa de gestionar estos cambios manualmente. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-05. RF-06 |
| **Documentos** | Comprobante de cancelación/reprogramación de turno. |
| **Argumentos de factibilidad** | La cancelación libera el slot para que vuelva a estar disponible, la reprogramación combina una cancelación con una nueva reserva en la misma operación. |
| **Métodos de verificación** | Prueba funcional: Cancelar un turno y verificar que vuelva a la agenda pública como disponible. Reprogramar un turno y verificar que el turno original quede liberado y el nuevo quede confirmado. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Cancelación de turnos o suspensión de agenda por imprevistos |
| **ID** | RF-09 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al médico o al personal administrativo cancelar un turno específico o suspender un periodo de tiempo completo de la agenda por motivos imprevistos o de fuerza mayor. |
| **Términos** | Personal administrativo, personal médico, suspension |
| **Justificación** | Es necesario mantener la agenda actualizada y reflejar la disponibilidad de turnos real ante situaciones inesperadas para evitar que pacientes asistan en vano. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-06 |
| **Documentos** | Reglamento interno de licencias y francos del personal médico. Calendario oficial de feriados nacionales (Ministerio del Interior). Protocolo institucional de contingencias y cancelación de servicios asistenciales. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza implementando una función en la interfaz de gestión que permita seleccionar un turno individual o un rango de fechas/horas y actualice su estado a "Cancelado" en la base de datos, bloqueando simultáneamente esos espacios para impedir futuras reservas. |
| **Métodos de verificación** | Un médico inicia sesión con su cuenta con credenciales de médico, accede a la vista de gestión de agenda, selecciona un turno ya reservado o un bloque horario en estado “disponible” y selecciona la opción "Cancelar turno/Suspender horarios”. Luego se verifica que el turno/bloque haya cambiado de horario correctamente y comprobar que los horarios suspendidos ya no figuren como disponibles para ser reservados. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Notificación automática por cancelación de turno |
| **ID** | RF-10 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe notificar automáticamente , por correo electrónico , a cada paciente cuyo turno reservado haya sido cancelado por el médico o personal administrativo. La notificación debe incluir los datos del turno cancelado (médico,especialidad,fecha y hora) y la causa de la cancelación y un link que mande al usuario directo a la reprogramación del turno. |
| **Términos** | Reprogramación por turno cancelado. |
| **Justificación** | Este requerimiento es necesario porque mantiene al usuario informado sobre el estado de su turno y al mismo tiempo evita que personas asistan a la sala médica cuando su turno ya no existe ,lo cual generaría un malentendido y a su vez una |

| | |
|---|---|
| | mala imagen para la sala médica . |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-03,RF-09 |
| **Documentos** | Comprobante de cancelación de turno. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza creando un sistema de notificación automática , que se active al momento en el que un turno cambia al estado “cancelado”.De manera que se le envíe la notificación al paciente. |
| **Métodos de verificación** | Con un turno reservado por un paciente , desde el rol de médico cancelarlo especificando un motivo y verificar que el paciente reciba la notificación pertinente , con fecha, hora , médico y especialidad, causa de cancelación y el link para reprogramar el turno.Luego repetir la prueba desde el lado del personal administrativo . |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Registro y actualización del inventario/stock de vacunas disponibles |
| **ID** | RF-11 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema permite dar de alta y actualización de vacunas con tipo, lote, vencimiento y cantidad. |
| **Términos** | Stock de vacunas. |
| **Justificación** | Es necesario para mantener la trazabilidad de cada vacuna y control de stock de vacunas. |
| **Prioridad** | Media/Alta. |
| **Dependencias** | RF-23 |
| **Documentos** | Calendario Nacional de Vacunación y manual de cadena de frío. |
| **Argumentos de factibilidad** | Cumple normativas de trazabilidad de biológicos y auditoría sanitaria. |
| **Métodos de verificación** | Trazabilidad inmutable de usuario, fecha y lote por movimiento. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Asignación y reserva de turnos específicos para vacunación |
| **ID** | RF-12 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a los usuarios con rol de enfermera o administrador asignar turnos específicos para vacunación, condicionando la reserva a la disponibilidad de stock físico de las vacunas en la sala médica. Los pacientes van de forma presencial a solicitar el turno. |
| **Términos** | Enfermeras, stock de vacunas, turno de vacunación. |
| **Justificación** | Es indispensable para organizar la asistencia de los pacientes a vacunarse y |

| | |
|---|---|
| | garantizar que no se otorguen citas si no hay dosis en stock, evitando inconvenientes con pacientes. |
| **Prioridad** | Media/Alta. |
| **Dependencias** | RF-11 |
| **Documentos** | Manual de procedimientos del Vacunatorio de la Sala Médica. Calendario Nacional de Vacunación (Ministerio de Salud de la Nación). Normativa sobre Trazabilidad y Control de Stock de Medicamentos y Vacunas (ANMAT). |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza implementando un control de validación al momento de solicitar el turno. El sistema consultará la tabla de inventario en la base de datos y solo permitirá la confirmación si la cantidad de la vacuna requerida es mayor a cero. Al confirmar, se puede descontar (o reservar lógicamente) una unidad del stock disponible. |
| **Métodos de verificación** | La enfermera inicia sesión en el sistema , luego ingresa las credenciales válidas del paciente, selecciona la opción de reservar turno de vacunación y dependiendo del stock de la vacuna es aceptado o rechazado. En caso de ser aceptado, revisar que el turno haya sido asignado correctamente, caso contrario, revisar que el sistema haya impedido la reserva, indicando al usuario que no hay disponibilidad de dosis para esa vacuna. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Generación de alertas automáticas por bajo stock de vacunas críticas |
| **ID** | RF-13 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe monitorear continuamente el inventario de vacunas catalogadas como "críticas" y generar alertas automáticas (notificaciones en pantalla, correos o mensajes) al personal responsable cuando el nivel de stock caiga por debajo del umbral mínimo definido para cada lote o insumo. |
| **Términos** | Vacuna crítica, Umbral de stock mínimo, Alerta automática, Inventario, Punto de reorden. |
| **Justificación** | Prevenir el desabastecimiento de insumos biológicos esenciales, garantizando la continuidad de las jornadas de vacunación y reduciendo riesgos para la salud pública o institucional. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-11 |
| **Documentos** | Plantilla de notificación urgente a responsables. |
| **Argumentos de factibilidad** | Implementable mediante tareas programadas (cron jobs) o disparadores en la base de datos (triggers) que comparen el conteo de stock disponible contra el umbral en cada transacción o intervalo predeterminado. |

| | |
|---|---|
| **Métodos de verificación** | Pruebas de integración registrando la salida o consumo de un lote de vacunas críticas hasta superar el umbral mínimo, comprobando que la alerta se cree en la base de datos y se envíe la notificación correspondiente al usuario designado. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Registro de cobertura médica/obra social del paciente y validación |
| **ID** | RF-14 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir registrar la obra social o prepaga del paciente y realizar la validación de la cobertura para la atención médica o consulta. |
| **Términos** | Paciente, cobertura médica, obra social, validación de obra social. |
| **Justificación** | Es necesario para agilizar el proceso de recepción, informar correctamente los costos para el paciente antes de la consulta y permitir a la administración liquidar correctamente las prestaciones a las obras sociales o cobrar los montos particulares necesarios. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-06 |
| **Documentos** | Documentos con información relevante para este requerimiento. |
| **Argumentos de factibilidad** | Por qué / de qué manera se garantiza que puede cumplirse. |
| **Métodos de verificación** | Cómo se verificará que se cumple. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Procesamiento de pagos para consultas particulares |
| **ID** | RF-15 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a los pacientes abonar consultas particulares a través de una pasarela de pago integrada, registrando la transacción una vez confirmado el pago. |
| **Términos** | Consulta particular (Atención abonada directamente por el paciente sin intermediación de una obra social prepaga). Pasarela de pago (servicio externo que procesa la transacción financiera) |
| **Justificación** | Digitaliza el cobro de consultas particulares, uno de los objetivos explícitos de POS. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-06 (el pago se asocia a un turno confirmado) |
| **Documentos** | Orden o solicitud de cobro de consulta particular. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se implementa mediante la integración con una pasarela de pago externa (vía API). |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Emisión y descarga de comprobantes/facturas digitales |
| **ID** | RF-16 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir emitir, consultar y descargar comprobantes o facturas digitales correspondientes a las transacciones y pagos realizados por consultas particulares o prestaciones médicas. |
| **Términos** | Factura/Comprobante digital, paciente, transacción |
| **Justificación** | Es fundamental para dar transparencia fiscal y administrativa al proceso de cobro, respaldar contablemente los ingresos de la sala médica y permitir que los pacientes dispongan de una constancia de pago digital válida para sus registros o reintegros. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-15 |
| **Documentos** | Normativa de Facturación Electrónica de la AFIP (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos - Factura A/B/C). Ley Nº 24.240 (Defensa del Consumidor - Información al Usuario y Obligación de Entrega de Comprobante). Reglamento Interno de Facturación y Contabilidad de la Sala Médica. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza mediante la generación automática de documentos PDF respaldados en el backend tras el procesamiento del pago. Se puede integrar o simular la emisión mediante servicios web de facturación (Web Services de AFIP / pasarelas de pago), almacenando la URL/archivo del comprobante asociado al ID de la transacción para su posterior descarga. |
| **Métodos de verificación** | Un usuario con credenciales de paciente inicia sesión, realiza el pago exitosamente de una consulta médica y verifica que el sistema genere automáticamente el comprobante digital correspondiente y lo asocie al historial de pagos del paciente. Por último, se verifica que la opción de descargar o visualizar factura genere un archivo formato pdf con la información correcta. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Carga de diagnósticos, indicaciones y tratamientos en la ficha digital. |
| **ID** | RF-17 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir la carga de diagnósticos, indicaciones y tratamientos |
| **Términos** | Ficha digital (registro electrónico del historial clínico de un paciente) |

| | |
|---|---|
| **Justificación** | Es el requerimiento base del módulo de historia clínica. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-06 |
| **Documentos** | Ley y normativa de Historia Clínica Electrónica y protección de datos. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se implementa como un formulario estructurado, vinculado al turno atendido, no presenta complejidad técnica relevante. |
| **Métodos de verificación** | Prueba funcional: un médico marca un turno como “atendido”, carga diagnóstico/indicaciones/tratamiento y se verifica que la información quede correctamente asociada a la ficha del paciente correspondiente. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Consulta remota del historial médico por parte del paciente. |
| **ID** | RF-18 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al paciente autenticado acceder y visualizar su historial clínico desde la plataforma web o la aplicación móvil, mostrando diagnósticos, tratamientos y fecha de las atenciones registradas por los médicos. |
| **Términos** | Historial clínico, Ficha del paciente, Diagnóstico, Tratamiento, Consulta remota. |
| **Justificación** | Permite brindar una experiencia más ágil y digital al paciente, dándole acceso inmediato a su información de salud sin necesidad de acudir o contactar presencialmente a la sala médica. |
| **Prioridad** | Alta. |
| **Dependencias** | RF-17 |
| **Documentos** | Resumen descargable de Historia Clínica del paciente. |
| **Argumentos de factibilidad** | Viable mediante la implementación de un backend que consuma la base de datos centralizada de historias clínicas, exponiendo endpoints seguros (API REST) accesibles tanto por la plataforma web como por la app móvil. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas de integración y de interfaz de usuario (UI): verificar que un paciente autenticado visualice únicamente sus propios registros clínicos cargados previamente por el médico de forma precisa y legible. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Reporte de turnos atendidos/cancelados por especialidad |
| **ID** | RF-19 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe poder generar un reporte que muestre la cantidad de turnos atendidos y cancelados, discriminados por especialidad médico, en un período seleccionable. |
| **Términos** | Turno atendido, Turno cancelado. |

| | |
|---|---|
| **Justificación** | Permite a los administradores evaluar la operatividad de cada especialidad y detectar patrones de cancelación. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-04 - RF-09 |
| **Documentos** | Registros consolidados de estados de turnos (Atendido/Cancelado/Ausente).tendido/Cancelado/Ausente). |
| **Argumentos de factibilidad** | Se puede implementar mediante una consulta agregada sobre datos ya existentes en el sistema de turnos, no requiere procesamiento adicional más allá de filtros por rango de fechas. |
| **Métodos de verificación** | Prueba funcional: generar el reporte para un período con turnos en distintos estados y especialidades, y verificar que los totales coinciden con los datos cargados en el sistema. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Generación de reporte de stock y consumo de vacunas |
| **ID** | RF-20 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a los usuarios con el rol administrador generar y visualizar reportes detallados sobre el estado del stock actual de vacunas y el consumo/aplicación y el consumo/aplicación de las mismas en un rango de fechas determinado. |
| **Términos** | Reporte administrativo, Stock de vacunas, Consumo de vacunas, Alerta de bajo stock, Administrador. |
| **Justificación** | Necesario para optimizar la gestión interna de la sala médica, permitir un control eficiente del inventario de vacunas y respaldar la toma de decisiones administrativas en la compra de insumos. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-11, RF-12 |
| **Documentos** | Documentos con información relevante para este requerimiento. |
| **Argumentos de factibilidad** | Viable mediante la ejecución de consultas agregadas (SQL/ORM) sobre las tablas de inventario y registro de aplicaciones de vacunas, exportando o renderizando los datos en paneles de control y formatos descargables (ej. PDF/Excel). |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales de generación de reportes: comprobar que los datos consolidados coincidan con el stock cargado por las enfermeras y las dosis registradas como aplicadas en el período seleccionado. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Generación de reporte de ingresos por pagos y ausentismo de pacientes |
| **ID** | RF-21 |
| **Categoría** | Funcional |

| | |
|---|---|
| **Descripción** | El sistema debe permitir a los administradores generar y consultar reportes sobre los ingresos financieros obtenidos por pago de consultas y la tasa de ausentismo de los pacientes en un periodo de tiempo determinado. |
| **Términos** | Administrador, reporte de ingresos, ausentismo. |
| **Justificación** | Necesario para la gestión gerencial y financiera de la sala médica, permitiendo evaluar la facturación obtenida, medir el impacto económico del ausentismo y tomar decisiones operativas para optimizar el aprovechamiento de la agenda médica. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-04, RF-15, RF-16 |
| **Documentos** | Reglamento interno de administración financiera y contabilidad de la sala médica. Manual de procedimientos para la gestión de cobros y control de gestión. Normativa contable y tributaria de la AFIP aplicable a prestaciones de salud. Ley Nº 25.326 (Protección de Datos Personales). |
| **Argumentos de factibilidad** | Se garantiza mediante la ejecución de consultas SQL de agregación en la base de datos, realizando un cruce de información entre la tabla de pagos/facturación y la tabla de turnos filtrados por rango de fechas y estado de atención ("atendido" vs "ausente"). Los resultados se presentarán mediante tablas/gráficos interactivos en la interfaz y/o mediante archivos exportables (PDF, Excel/CSV). |
| **Métodos de verificación** | Se inicia sesión con credenciales de administrador, se accede al módulo de reportes administrativos, se define un rango de fechas y se solicita la generación de un reporte de ingresos y ausentismo, se verifica que el reporte muestre correctamente el total acumulado de ingresos recaudos y la estadística/porcentaje de ausentismo entre pacientes. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Registro autogestionado de cuenta de paciente |
| **ID** | RF-22 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir que una persona cree por sí misma su cuenta de paciente, informando sus datos personales (nombre, apellido, DNI, correo electrónico) y una contraseña. La cuenta creada queda asociada al rol Paciente. |
| **Términos** | Cuenta de usuario (credencial con la que una persona accede al sistema). Rol (conjunto de funciones habilitadas para un tipo de usuario). Paciente. |
| **Justificación** | El cliente definió que los pacientes crean sus propias cuentas, sin intervención del personal de la sala. Es la puerta de entrada al circuito de reserva de turnos: sin cuenta de paciente ninguna reserva puede asociarse a una persona. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | Ninguna. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. |
| **Argumentos de factibilidad** | Se dispone de una base de datos capaz de almacenar los datos personales de los pacientes y de verificar que una misma persona no quede registrada dos veces. |

| | |
|---|---|
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: una persona sin cuenta completa el formulario de registro y se verifica que pueda iniciar sesión y acceder a la interfaz del rol Paciente. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Inicio de sesión mediante correo electrónico |
| **ID** | RF-23 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a todos los usuarios iniciar sesión mediante su correo electrónico y su contraseña, y debe presentarles la interfaz correspondiente al rol que tienen asignado. |
| **Términos** | Credenciales (correo electrónico y contraseña con los que el usuario se identifica). Rol. |
| **Justificación** | El cliente indicó que todos los usuarios ingresan con su correo electrónico. Es precondición de toda función que dependa de la identidad del usuario, como la consulta de la agenda propia del médico o del historial del paciente. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | La sala cuenta con correo electrónico para todo su personal, y los pacientes informan el suyo al momento de registrarse. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: se inicia sesión con una cuenta de cada rol y se verifica que cada una acceda a la interfaz que le corresponde y sea rechazada ante credenciales incorrectas. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Creación de cuentas del personal de la sala por el administrador |
| **ID** | RF-24 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al administrador crear las cuentas de los médicos y de las enfermeras, asignando el rol correspondiente en el mismo momento del alta. |
| **Términos** | Administrador. Alta de cuenta. Asignación de rol. |
| **Justificación** | El cliente definió que el personal de la sala no se autogestiona la cuenta: es el administrador quien la crea y quien le asigna el rol en el momento del alta y no con posterioridad. Esto mantiene bajo control quién puede operar como médico o como enfermera. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-23. |
| **Documentos** | Minuta de las consultas con el cliente del 03/09/2026 y del 17/09/2026. Nómina de profesionales de la sala médica. |
| **Argumentos de factibilidad** | La sala dispone de la nómina de sus tres médicos y sus dos enfermeras, y cuenta con una persona con rol de administrador encargada de realizar las altas. |

| | |
|---|---|
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: el administrador da de alta un médico y una enfermera, y se verifica que cada uno pueda iniciar sesión con el rol que se le asignó en el alta. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Diferenciación de la interfaz según el rol del usuario |
| **ID** | RF-25 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe presentar a cada usuario el conjunto de pantallas y acciones propio de su rol (paciente, médico, enfermera o administrador), sin exponerle las funciones que corresponden a los demás roles. |
| **Términos** | Rol. Interfaz de usuario. Permisos. |
| **Justificación** | El cliente pidió expresamente una clara distinción de pantallas por rol. Además de facilitar el uso, evita que un usuario acceda a funciones ajenas a su responsabilidad, en particular a la información clínica. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-23. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 17/09/2026. Enunciado del Proyecto PSS-2026, Enunciado 2 ("interfaces de usuario separadas y específicas para pacientes, médicos y administradores"). |
| **Argumentos de factibilidad** | Los cuatro roles y las funciones que corresponden a cada uno quedaron definidos por el cliente, de modo que la separación de pantallas puede establecerse desde el inicio del desarrollo. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: se inicia sesión con un usuario de cada rol y se verifica que solo estén disponibles las acciones previstas para ese rol y que las demás no sean accesibles. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Permisos de las funciones de médico y de paciente por el administrador |
| **ID** | RF-26 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al administrador realizar las mismas acciones que puede realizar un médico y las que puede realizar un paciente, además de las funciones propias de su rol. |
| **Términos** | Administrador. Permisos. Rol. |
| **Justificación** | El cliente indicó que el administrador puede hacer todo lo que hace un médico y todo lo que hace un paciente, de modo de poder cubrir la operación de la sala ante la ausencia del personal o ante solicitudes presenciales. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-25. |
| **Documentos** | |
| **Argumentos de factibilidad** | Las funciones de los roles médico y paciente ya quedan definidas por los |

| | |
|---|---|
| | requerimientos correspondientes, por lo que alcanza con habilitarlas también para el rol administrador. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: el administrador accede a las funciones propias del rol médico y del rol paciente y se verifica que pueda ejecutarlas sin necesidad de una cuenta adicional. |

**Complementos del módulo 1 — Gestión de agenda médica**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Modificación de los horarios de atención por el administrador |
| **ID** | RF-27 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir únicamente al administrador modificar los horarios de atención cargados para un médico. El médico carga sus horarios una sola vez, al momento del alta, y no puede modificarlos por sí mismo. |
| **Términos** | Horario de atención (franja fija en la que un profesional atiende, definida una única vez). Administrador. |
| **Justificación** | El cliente definió que los horarios de atención se cargan una única vez y que solo el administrador puede cambiarlos. Esto evita que la agenda ya publicada se altere de manera descontrolada y que los pacientes pierdan turnos ya reservados. |
| **Prioridad** | Media/Alta. |
| **Dependencias** | RF-01 y RF-25. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | Los horarios de cada médico quedan almacenados en el sistema y la sala cuenta con un administrador responsable de mantenerlos actualizados. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: un médico intenta modificar su horario y se verifica que la acción no esté disponible; el administrador realiza la modificación y se verifica que el cambio se refleje en la agenda publicada. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Selección de un turno como no disponible por el médico |
| **ID** | RF-28 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al médico marcar un turno determinado de su agenda como no disponible, de modo que ese horario deje de ofrecerse a los pacientes para su reserva. |
| **Términos** | Turno no disponible (turno que el médico retira de la oferta sin bloquear toda la jornada). Agenda. |
| **Justificación** | El cliente indicó que el médico puede marcar turnos como no disponibles ante situaciones puntuales. A diferencia del bloqueo de agenda, permite retirar un único horario sin afectar el resto del día. |
| **Prioridad** | Baja. |

| | |
|---|---|
| **Dependencias** | RF-02. |
| **Documentos** | Minuta de las consultas con el cliente del 03/09/2026 y del 17/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | Cada turno tiene un estado registrado en el sistema, de modo que puede pasarse al estado no disponible y excluirse de la vista de reserva. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: el médico marca un turno libre como no disponible y se verifica, desde la interfaz del paciente, que ese horario ya no aparezca entre los turnos reservables. |

**Complementos del módulo 2 — Reserva de turnos**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Registro de la asistencia del paciente al turno |
| **ID** | RF-29 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al médico asignado a un turno registrar si el paciente asistió o no asistió a la consulta, dejando el turno en el estado correspondiente. |
| **Términos** | Asistencia. Inasistencia. Estado de turno (atendido o ausente). |
| **Justificación** | El cliente definió que es el propio médico asignado al turno quien determina la asistencia del paciente. Es el dato que alimenta el reporte de ausentismo y el cobro por inasistencia, que hoy no tienen origen en ningún otro requerimiento. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-04 y RF-06. |
| **Documentos** | Minuta de las consultas con el cliente del 03/09/2026 y del 17/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | El médico dispone de su hoja de trabajo diaria con los turnos del día, sobre la cual puede registrar la asistencia de cada paciente al finalizar la consulta. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: el médico registra un paciente como ausente y se verifica que el estado del turno cambie y que la inasistencia se refleje en el reporte de ausentismo. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Reserva de turno por el administrador a solicitud presencial |
| **ID** | RF-30 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al administrador reservar un turno a nombre de un paciente cuando la solicitud se realice de forma presencial o telefónica en la sala médica. |
| **Términos** | Reserva presencial (turno solicitado en el mostrador de la sala y cargado por el personal administrativo). Administrador. |
| **Justificación** | El cliente indicó que los turnos también se piden de forma física y que los administrativos son quienes los cargan. Sin esta función, esos turnos quedarían fuera del sistema y la agenda dejaría de reflejar la ocupación real del médico. |

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-06 y RF-25. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 17/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | El administrador cuenta con acceso a la agenda publicada y a los datos de los pacientes registrados, de modo que puede completar la reserva en su nombre. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: el administrador reserva un turno a nombre de un paciente registrado y se verifica que el turno aparezca tanto en la agenda del médico como en el panel de turnos del paciente. |

**Complementos del módulo 3 — Gestión de vacunas**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Aprobación de la solicitud de turno de vacunación por la enfermera |
| **ID** | RF-31 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe registrar las solicitudes de turno de vacunación en estado pendiente y permitir que una enfermera o el administrador las apruebe o las rechace. El turno de vacunación solo queda confirmado una vez aprobado. |
| **Términos** | Solicitud de turno de vacunación. Turno pendiente (solicitud registrada y aún no resuelta). Aprobación. Rechazo. |
| **Justificación** | El cliente definió que todo pedido de turno de vacunación debe ser aprobado por una enfermera y que el sistema no puede confirmarlo de forma automática, dado que la asignación depende de la disponibilidad real de la vacuna en la sala. |
| **Prioridad** | Media. |
| **Dependencias** | RF-11 y RF-12. |
| **Documentos** | Minuta de las consultas con el cliente del 03/09/2026 y del 17/09/2026. Manual de procedimientos de enfermería de la sala médica. |
| **Argumentos de factibilidad** | La sala cuenta con dos enfermeras que revisan las solicitudes de vacunación, y el sistema registra el estado de cada solicitud hasta su resolución. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: un paciente solicita un turno de vacunación y se verifica que quede en estado pendiente; una enfermera lo aprueba y se verifica que pase a confirmado; se rechaza otra solicitud y se verifica que no quede confirmada y que el paciente sea informado. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Definición del nivel de stock crítico de cada vacuna |
| **ID** | RF-32 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a las enfermeras y al administrador definir, para cada vacuna del inventario, la cantidad mínima a partir de la cual su stock se considera crítico. |

| | |
|---|---|
| **Términos** | Stock crítico (cantidad mínima por debajo de la cual una vacuna requiere reposición). Umbral. Vacuna. |
| **Justificación** | El cliente indicó que cada vacuna tiene su propio nivel crítico y que lo determinan las enfermeras o el administrador. Sin ese valor cargado, las alertas automáticas por bajo stock no pueden emitirse. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-11. |
| **Documentos** | Minuta de las consultas con el cliente del 03/09/2026 y del 17/09/2026. Calendario Nacional de Vacunación. |
| **Argumentos de factibilidad** | El inventario registra cada vacuna de forma individual, de modo que puede asociarse un umbral propio a cada una de ellas. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: se define un umbral para una vacuna, se reduce su stock por debajo de ese valor y se verifica que se emita la alerta correspondiente y que no se emita para las vacunas que siguen por encima de su umbral. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Alta de nuevas vacunas en el inventario por la enfermera |
| **ID** | RF-33 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a las enfermeras incorporar al inventario vacunas que no estuvieran previamente registradas, además de actualizar el stock de las ya existentes. |
| **Términos** | Inventario de vacunas. Alta de vacuna. |
| **Justificación** | El cliente aclaró que las enfermeras agregan vacunas al stock y no se limitan a administrar las que ya estaban registradas. Sin esta función, el inventario quedaría fijo a la carga inicial. |
| **Prioridad** | Media/Alta. |
| **Dependencias** | RF-11. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. Calendario Nacional de Vacunación. |
| **Argumentos de factibilidad** | Las enfermeras son quienes reciben las vacunas en la sala y disponen de la información necesaria para darlas de alta en el inventario. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: una enfermera incorpora una vacuna no registrada previamente y se verifica que quede disponible para cargarle stock, definirle un nivel crítico y asignarle turnos. |

**Complementos del módulo 4 — Gestión de pagos y coberturas**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Definición del valor de la consulta por cada médico |
| **ID** | RF-34 |

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe permitir que cada médico defina el valor de su consulta particular, y debe tomar ese valor al registrar el pago del turno correspondiente. |
| **Términos** | Valor de consulta. Consulta particular (atención abonada por el paciente sin cobertura médica). |
| **Justificación** | El cliente definió que el valor de la consulta no es unificado para la sala, sino que cada médico establece el suyo. El registro del pago y el cobro por inasistencia dependen de este dato. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-25. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. Tabla de aranceles de la sala médica. |
| **Argumentos de factibilidad** | Cada médico conoce el valor que cobra por su consulta, y el sistema puede almacenarlo junto con el resto de sus datos profesionales. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: dos médicos definen valores distintos y se verifica que, al registrar el pago de un turno, se tome el valor correspondiente al médico que atiende ese turno. |

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Cobro de la totalidad del turno ante la inasistencia del paciente |
| **ID** | RF-35 |
| **Categoría** | Funcional |
| **Descripción** | El sistema debe registrar, cuando un turno queda marcado como ausente, una deuda a nombre del paciente por el valor total de la consulta del médico correspondiente. |
| **Términos** | Inasistencia. Deuda del paciente. Valor de consulta. |
| **Justificación** | El cliente indicó que al paciente que falta a un turno se le cobra la totalidad del valor de la consulta. Es la consecuencia económica de la inasistencia y alimenta el reporte de ingresos y ausentismo. |
| **Prioridad** | Baja. |
| **Dependencias** | RF-29 y RF-34. |
| **Documentos** | Minuta de la consulta con el cliente del 03/09/2026. |
| **Argumentos de factibilidad** | El sistema conoce el estado de cada turno y el valor de la consulta de cada médico, de modo que dispone de los datos necesarios para registrar el importe adeudado. |
| **Métodos de verificación** | Pruebas funcionales: se marca un turno como ausente y se verifica que quede registrada la deuda por el valor total de la consulta de ese médico, y que no se registre deuda alguna cuando el turno se marca como atendido. |